Plano de alterações — reunião de 29/10

A partir de *Reunião de alinhamento: ajustes do site* (29/10/2026, Thais, Vivi, Lari, Kauê e Rafael), cruzado com o site publicado em 28/10 (commit `9a356c2`).

Site: prescricao.conversion.com.br

Atualizado em 29/10/2026 (noite): os 21 pontos "dá para fazer" foram feitos e publicados no ambiente de revisão, incluindo as duas reestruturações (Recursos em abas, Para quem em sequência com cards por perfil). Imagens provisórias onde ainda não há foto. Detalhes em `docs/registro-26-10-2026.md`, seção 9.

Situação em 29/10/2026: a última versão foi bem recebida. O combinado é fechar o layout agora e deixar ajustes de conteúdo para depois. O diagnóstico geral é "muito texto e pouco respiro"; os pedidos se concentram em Home, Recursos e Para quem. A agência envia o material atualizado em 30/10; a Afya consolida os pontos de todos em um único documento depois da reunião interna (03 ou 04/11); versão final até o meio da semana de 09 a 13/11.

21
feitos

6
faltam contexto ou material

0
não dá

Feito publicado no ambiente de revisão em 29/10

Falta contexto decisão, confirmação ou material da Afya; feito com provisório quando possível

Não dá depende de algo que o site estático não tem

Antes de tudo: o que a ata define

- **Feito** Esta rodada é de layout, não de conteúdo. Texto só muda onde a mudança de estrutura obriga (por exemplo, unir dois passos em um). Nada novo é escrito; o que sair da tela já existe em outra página (Dúvidas, Recursos).

- Feito Entrega em duas rodadas: os ajustes pontuais (passos da home, rolagem, caixa do dispensador, espaçamentos) hoje; a reestruturação de Recursos e Para quem publicada em 30/10, com imagens provisórias onde ainda não há foto. Depois disso, o site fica parado até chegar o documento consolidado.
- Falta contexto A "proposta enviada" dos três passos é a imagem da ata, com fundo escuro e círculos rosa. A própria ata diz para ficar "com a cor do site atual e não precisar mudar para background escuro": aplicamos o conteúdo da proposta nas cores do site. Se a ideia era a arte escura, é só dizer.

1. Home: passo a passo em 3 passos

Busque e monte → Assine → Envie

Feito

Ata · item 1 · hoje são quatro passos (Busque, Monte, Assine, Envie), decisão nossa de 27/10

- Feito Unir "Busque" e "Monte" em "Busque e monte", com a linha da proposta: "Encontre medicamentos, exames e vacinas e ajuste a posologia sugerida." Os outros dois seguem como na proposta: "Assine digitalmente com o certificado que você já tem." e "Mande para o paciente por WhatsApp, link, PDF ou impressão."
- Feito Telas de cada passo como na proposta: 1) busca "Amoxi" com a lista Amoxicilina 500 mg (cápsula) e 875 mg (comprimido); 2) "Assinatura digital" com BirdID, VaultID, VIDaaS e o botão Assinar; 3) "Prescrição concluída", Assinada, WhatsApp e "Link · PDF · Imprimir". Três colunas; a grade já aceita.
- Feito Cores atuais do site: fundo claro, círculo numerado em azul, telas do celular como estão. Sem fundo escuro.
- Feito A versão completa, com os oito blocos (Buscar, Montar, Reaproveitar, Revisar, LME, Assinar, Enviar, Acompanhar), fica só em Recursos. Os links "Como funciona" do rodapé continuam apontando para lá.

2. Recursos: corrigir a rolagem

Rolagem engasgando entre 01 Buscar e 02 Montar

Feito

Ata · item 2 · captura com a barra de etapas e o bloco "Parta de uma posologia sugerida"

- Feito **Diagnóstico.** Em teste automatizado (Edge, 1440 px) a página rola a 60 quadros por segundo constantes, então o engasgo não é de carga da página e sim de custo de pintura na máquina de quem apresentava, somado ao compartilhamento de tela. Três coisas pesam exatamente nesse trecho: a barra de etapas fixa tem desfoque de fundo (blur) e passa por cima de telas grandes com sombra; o cursor piscando da busca e o pulso dos marcadores do topo são animações infinitas, que repintam o tempo todo; e o marcador da etapa ativa chama `scrollIntoView` a cada troca com a rolagem suave ligada na página, o que pode disputar com a rolagem do usuário.
- Feito **Correção.** Barra de etapas com fundo sólido, sem desfoque; o chip ativo rola a própria barra sem `scrollIntoView`; cursor e pulso só enquanto estão na tela (e parados fora dela); sombras das telas mais leves; blocos fora da tela deixam de ser pintados (`content-visibility`). Se o item 3 virar abas, a barra fixa some e o problema some junto.
- Falta contexto Confirmar depois da correção na máquina de quem apresentou, de preferência fora do Meet. Se ainda engasgar, precisamos saber navegador e se a página estava sendo compartilhada.

Para quem, farmácia: caixa sobreposta e texto fora da caixa

Feito

Ata · item 2, segunda captura (Para quem › Farmácias, bloco "Dispensador Afya")

- Feito **Causa encontrada.** A caixa "Dispensador Afya" usa a grade de três colunas mesmo marcada para uma (a regra de coluna única não existe na folha de estilo), então fica com um terço da largura; o endereço farmacia.iclinicrx.com.br não quebra e sai da caixa. E a caixa encosta na tabela "O que muda para a farmácia" porque o bloco não tem margem acima.
- Feito **Correção.** A ata pede trocar esse bloco por imagem (item 4). Até a foto chegar, a caixa vira a tela do dispensador em largura total, com 56 px de margem acima, e o endereço vira link que quebra linha. O texto e os dois botões ficam como estão.

3. Recursos: menos texto, mais respiro

Página no padrão do Prontuário do iClinic

Feito

Ata · item 3 · referência: iclinic.com.br/funcionalidades/prontuario-eletronico/ · hoje: 8 blocos alternando texto e tela, 82 parágrafos e 62 itens de lista

- Feito **Recursos em abas, um por vez.** Os oito blocos viram abas no padrão da referência (Campos, Resumo IA, Prescrição...): Buscar, Montar, Reaproveitar, Revisar, LME, Assinar, Enviar, Acompanhar. Cada aba mostra uma tela à direita e, à esquerda, título, uma ou duas linhas e até três bullets. A barra de etapas fixa vira a própria barra de abas; sai o scroll-spy.
- Feito **O que sai de cada bloco.** Hoje cada um tem título, parágrafo, quatro a seis bullets e chips. Fica título, uma ou duas linhas e três bullets. Os bullets excedentes não somem do site: já estão na central de Dúvidas e nas páginas por especialidade.
- Feito **Itens secundários em cards curtos e chips.** "Na prática" (quatro passos) e os recursos específicos de cada produto (bloco "Escolha pelo jeito que você atende") viram grade de cards com ícone, título em negrito e uma linha. Os receituários da faixa da RDC seguem como chips.
- Feito **Ícones e respiro.** Ícone por etapa (o sprite já tem um para cada), distância entre blocos de 52 para cerca de 96 px, seções com mais altura, menos sombras.
- Feito **Na prescrição, uma imagem limpa.** O bloco de prescrição deixa de mostrar os cards de medicamento e posologia: fica uma tela única, limpa, com um item só, sem chips nem rodapé. Enquanto não chega o print oficial, é a tela em HTML simplificada.
- Feito **Alinhamento à esquerda.** A ata pede avaliar. Proposta: texto sempre à esquerda e tela à direita, como na referência, em vez de alternar. Aplicamos assim nas abas e a Afya confere no site.
- Falta contexto **Alternar telas com fotos reais.** Temos só as três fotos das personas (plantão, consultório, estudos) e as dos depoimentos. Entram como quebra de leitura entre os grupos de abas, provisoriamente; as definitivas vêm do Lucão.
- Falta contexto **Print oficial da tela de prescrição** (pedido desde 29/09). Troca direta quando chegar.

Como fica a ordem da página: topo com a receita e os marcadores → abas de recursos (um por vez) → foto → "Na prática" em cards curtos → contexto de uso por produto em cards → faixa da RDC → FAQ.

4. Para quem: estrutura e imagens por perfil

Perfis em sequência, com cards no topo como no Memed

Feito

Ata · item 4 · referência: memed.com.br · hoje: quatro abas (Médicos, Clínicas e consultórios, Pacientes, Farmácia) trocando o conteúdo ao clicar

- Feito **Sai o formato de abas.** Os quatro perfis ficam em sequência na mesma página, com âncoras (#medicos, #clinicas, #pacientes, #farmacias). O médico, ao rolar, vê também a proposta para paciente e farmácia. Os links do mega menu, do rodapé e de campanha continuam valendo, porque os ids são os mesmos.
- Feito **Cards por perfil no topo.** Quatro cards no estilo do Memed: foto, título ("Médicos", "Clínicas e consultórios", "Pacientes", "Farmácias"), duas ou três linhas e "Saiba mais" levando à âncora do perfil.
- Feito **Enxugar o que repete.** Com tudo na mesma página, "Do outro lado da receita" aparece uma vez (hoje está nos dois painéis de paciente e farmácia), a chamada final fica uma só e o quiz fica em Médicos. A página passa a ter cerca de 7 mil pixels de altura; o topo com os cards serve de índice.
- Feito **Bloco da farmácia vira imagem.** O card "Dispensador Afya" sai; entra uma imagem ao lado do texto e dos botões.
- Falta contexto **Fotos reais por perfil** (ata: pedir ao Lucão antes da reunião interna). Até chegar: médico com a foto do plantão, clínica com a do consultório, paciente com a de estudos e farmácia com a tela do dispensador no lugar da foto. As quatro são trocadas de uma vez quando as imagens chegarem.

5. Para quem: espaçamento na parte de Paciente

Títulos colados nos blocos de cima

Feito

Ata · item 5 · "O que muda para o paciente", "Como o paciente usa a receita digital"

- Feito **Medido.** "O que muda para o paciente" fica a 20 px da tela acima e "Como o paciente usa a receita digital" encosta na tabela (0 px). Na farmácia o mesmo título tem cerca de 40 px. Padrão novo: 56 px acima de cada título de bloco, em todos os perfis, inclusive médicos e clínicas, que têm o mesmo tipo de título ("O que muda na sua rotina", "O que muda na operação da clínica").
- Feito Conferir o mesmo espaçamento em todos os blocos de todos os perfis, já que a página vai ser remontada no item 4.
- Falta contexto "Conferir o mesmo problema no trecho do plano": não identificamos qual trecho. Pode ser a seção "A prescrição é uma parte. A gestão da clínica é o todo." (ponte com os planos do iClinic, em Clínicas). Vamos conferir todos de qualquer jeito; se for outro lugar, pedimos a captura.

Ordem sugerida

1. **Rodada 1, hoje (29/10), ajustes pontuais:** home em três passos; rolagem de Recursos; caixa do dispensador; espaçamentos do Para quem. Publicar no ambiente de revisão.
2. **Rodada 2, até 30/10, reestruturação:** Recursos em abas com cards curtos, ícones e respiro; Para quem em sequência com os cards por perfil (imagens provisórias). Publicar e enviar o material atualizado à Afya.
3. **Depois do documento consolidado (03 ou 04/11):** trocar as imagens provisórias pelas fotos do Lucão, aplicar os pontos novos e entregar a versão final até o meio da semana de 09 a 13/11.

O que falta saber ou receber

O quê	De quem	Trava
Fotos reais por perfil: médico, clínica, paciente, farmácia	Lucão (Afya)	Cards do Para quem e fotos entre os blocos de Recursos (vão com provisórias)
Print oficial da tela de prescrição	Afya	Imagem limpa em Recursos (vai com a tela em HTML)
Confirmação de que a rolagem ficou boa na máquina de quem apresentou	Quem apresentou	Nada: só fecha o item 2
Qual é o "trecho do plano" com espaçamento errado	Lari / Thais	Nada: conferimos todos
A proposta dos três passos era só o conteúdo ou também a arte escura?	Lari / Thais	Nada: vai nas cores do site, como a ata pede
Documento consolidado com os pontos de todos (incluindo Ani, Lucão, Victor e Kauê)	Afya, logo após a reunião interna	Versão final

Calendário combinado

Ação	Responsável	Prazo
Enviar material atualizado	Conversion	30/10
Pedir imagens por perfil ao Lucão; pedir ao Kauê revisão e pontos adicionais	Afya	Antes da reunião interna
Reunião interna de consolidação	Afya (todos)	03 ou 04/11
Enviar documento consolidado	Afya	Logo após a reunião interna
Implementar ajustes e entregar versão final	Conversion	Até o meio da semana de 09 a 13/11

Plano gerado em 29/10/2026 a partir da ata da reunião. Planos anteriores: `docs/plano-copy-wireframes-v9-26-10-2026.html`, `docs/plano-call-29-09-2026.html`.